

Síndrome dos ovários policísticos · Rotterdam

SOP exige "e2 critérios de Rotterdam: hiperandrogenismo, ovulação disfuncional, morfologia multicística — com exclusão de mimetizadores (tireoide, hiperprolactinemia, HAC).

Metabolismo

Lembre - Metabolismo

Rastreie DM/intolerância, dislipidemia e HAS. Mudança de estilo de vida é base — mesmo sem desejo gestacional imediato.

Fórmula de prova: hiperandrogenismo + anovulação + USG multicístico (2/3), após excluir outras causas.

Rotterdam (conceito)

2 de 3 criterios + exclusoes

HA clinico/lab + anovulacao + USG (2/3)

Excluir: TSH, prolactina, 17-OHP; gestacao se amenorreia

Tratamento por meta

- Ciclos/hiperandrogenismo sem gestar: ACO combinado (se sem CI)
- Hirsutismo: ACO ± antiandrógeno (espironolactona) com contracepção
- Resistência insulínica/DM: metformina como adjuvante
- Infertilidade anovulatória: letrozol (1ª em muitas diretrizes) / citrato de clomifeno

Diferenciais

Condição | Pista

Hiperprolactinemia | Galactorreia; PRL !'

Hipotireoidismo | TSH !'

HAC forma não clássica | 17-OHP !'; acne/hirsutismo precoce

Tumores androgênicos | Virilização rápida; testosterona muito alta

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

USG 'multifolicular' sozinho não fecha SOP em adolescente. Amenorreia prolongada: proteger endométrio (progestagênio/ACO) — risco de hiperplasia.